

Storia della Follia

Salute Mentale · Sessione 02 · 25.02.2026

Questa lezione affronta la domanda che attraversa tutta la psichiatria: la follia è una malattia del cervello o il prodotto delle passioni e della vita? Un dibattito antico che non è mai finito — e che definisce ancora oggi come curiamo le persone.

I due sguardi fondamentali sulla follia

Il prof Pezzoli apre con una provocazione: la storia della follia non è la storia di un'unica idea che migliora nel tempo. È la storia di **due sguardi in perenne conflitto**:

- Lo sguardo **organicista (Gehirnpsychiatrie)**: la follia è una malattia del cervello, un danno biologico, un meccanismo rotto.
- Lo sguardo **psicologico/delle passioni (Geistespsychiatrie)**: la follia nasce dall'eccesso emotivo, dalle ferite della vita, dalla disregolazione delle relazioni e degli affetti.

Questi due filoni si sono alternati, scontrati e a volte integrati nei secoli. Il prof sottolinea che oggi non sono risolti: entrambi sono ancora vivi nei dibattiti clinici e negli approcci terapeutici.

Il racconto di Donizetti: due follie in una storia

Per rendere concreta la dialettica, il prof usa la figura di **Gaetano Donizetti** (1797–1848), compositore d'opera.

La follia organica: Donizetti e la sifilide

Donizetti contrasse la **sifilide** in gioventù, descritta già da **Fracastoro** (1476–1553). La sifilide ha tre fasi; l'ultima, dopo una latenza di 10–30 anni, attacca il sistema nervoso centrale provocando la **paralisi progressiva**: irritabilità, disturbi del linguaggio, deterioramento cognitivo irreversibile.

Fu **Bayle**, nei primi decenni dell'Ottocento, a ipotizzare il legame sifilide–follia. Solo nel 1913 **Hideyo Noguchi** individuò il batterio *Treponema pallidum* nella corteccia cerebrale dei malati — prova biologica che quella follia era una malattia del cervello.

Nel 1847 Donizetti — ormai compromesso — fu internato con l'inganno nella casa di cura di Ivry-sur-Seine, fondata da Esquirol (allievo di Pinel). Poi riportato a Bergamo in carrozza attraverso il Reno, la Svizzera e il San Gottardo. I familiari gli facevano suonare le sue arie, ma nemmeno il tenore Rubini che gli cantò l'aria della *Lucia di Lammermoor* riuscì a "risvegliarlo". Donizetti morì nel 1848.

Questa è la follia **organica**: causata dal deterioramento del SNC, incomprensibile, inesorabile.

La follia delle passioni: Lucia di Lammermoor

La stessa opera racconta il secondo tipo di follia. Lucia è costretta dalla famiglia a sposare un uomo che non ama (la famiglia intercetta le sue lettere, fa credere che lui l'abbia abbandonata). La notte di nozze uccide il marito e ne esce in uno stato dissociativo: canta canzoni d'amore, è "altrove". Donizetti usa la **glassarmonica** per evocare musicalmente questa alterità — il suono del fantasma.

Questa è la follia **delle passioni**: ingiustizia, tradimento, costrizione — eccesso emotivo che travolge la ragione. Il prof sottolinea che questa follia ha una **quota di comprensibilità**: non condividiamo l'omicidio, ma capiamo la sofferenza che lo ha generato. Ci ritroviamo qualcosa.

"La follia di Lucia non è la follia che vive Donizetti nell'ultima fase della sifilide." — Pezzoli

Le due follie coesistono nella stessa storia: la malattia organica del compositore e la follia psicologica del personaggio che lui stesso aveva creato.

Percorso storico: dalle origini al Rinascimento

Grecia antica: la follia sacra e Ippocrate

In Grecia arcaica, la follia era interpretata come **possessione divina** o punizione degli dei. I luoghi di cura erano i templi sacri ad Asclepio, dio della medicina e fondatore degli Asclepidi — una sorta di "ordine dei medici" del V sec. a.C.

Ippocrate di Kos (~460–370 a.C.) fa il passo decisivo: emancipa la follia dalla magia. Dice che l'epilessia — il "male sacro" per eccellenza — ha la stessa natura di tutte le altre malattie. Niente più cause divine.

Introduce la **teoria degli umori**: quattro fluidi corporei il cui squilibrio genera malattia e carattere specifici. Pensala come quattro variabili di base di un sistema: se una va fuori controllo, tutto l'equilibrio crolla.

Umore	Elemento	Temperamento
Bile nera	Terra	Melanconico
Sangue	Aria	Sanguigno
Flegma	Acqua	Flemmatico
Bile gialla	Fuoco	Collerico

Chi segue questa teoria è detto **fluidista**. Il concetto di equilibrio come salute sopravvive fino a noi: il termine "squilibrato" viene direttamente da qui.

Empedocle (~490 a.C.) approfondisce: l'equilibrio si mantiene attraverso l'oscillazione tra poli contrari (caldo/freddo, umido/secco). Di qui il proverbio popolare della "doccia fredda" come rimedio ai bollori passionali — secoli di teoria medica condensati in un modo di dire.

Medioevo: pausa senza novità

Durante il Medioevo l'interpretazione della follia è mediata dalla religione. Non emerge nulla di genuinamente originale sul piano medico — solo compilazioni e antologie di testi antichi. Il prof cita **Teofane** (910 d.C.) e il suo *Compendium totius artis medicinae*: grandioso nel titolo, vuoto di contenuto.

Rinascimento e 1500–1600: torna il corpo

Con la rinascita delle scienze nel 1500, si riprende la teoria degli umori, ma emergono anche nuove ipotesi di localizzazione cerebrale della follia:

- **Girolamo Mercuriale** (1530–1606): studi sulla **catatonìa**
- **Johann Weyer** (1515–1588): prima descrizione delle **allucinazioni visive**; ipotizza che le "streghe" usino erbe psicoattive — non demonologia, ma corpo come causa

Con il 1600 si afferma il concetto di "**Homme Machine**" (uomo macchina): l'uomo come organismo fisico, sganciato dalla dimensione teologica. Sfondo: Descartes.

De Lamettrie e il meccanicismo (1747)

Julien Offroy de Lamettrie pubblica nel 1747 *L'uomo macchina*, sviluppando la visione meccanicistica in modo definitivo:

"Una macchina complicatissima il cui meccanismo non può venire scoperto a priori bensì può venire gradatamente e pazientemente rilevato dagli studi di medicina." (Preti, 1955)

De Lamettrie riprende i fluidisti e descrive come gli umori influenzino personalità e malattia. Le sue intuizioni anticipano la psichiatria positivista dell'Ottocento.

I nervi entrano in scena (Settecento)

Accanto ai fluidi, nel Settecento compare un nuovo protagonista: i **nervi**. Filamenti e cavi dell'organismo, sensibili, soggetti a eccitamento:

- **Pomme** (1760): introduce il concetto di "attacchi di nervi", che arriverà fino a noi
 - **William Cullen** (1777): conia il termine **nevrosi**, raccogliendo isteria e ipocondria
 - **G.M. Beard** (1839–1883): **nevrastenia** — l'"esaurimento nervoso" popolare — il cervello come una batteria che si scarica sotto il peso della vita moderna
-

Pinel: la grande svolta (fine 1700)

Philippe Pinel (1745–1826) è la figura centrale della transizione. Famoso per aver liberato i folli dalle catene al Bicêtre (1793) — gesto diventato quasi mitologico, ma il prof nota che la vera rivoluzione è concettuale.

Pinel cambia paradigma: la follia non è (o non è sempre) una malattia del cervello. Per la maggior parte dei casi la causa è nelle **passioni e nella vita morale** della persona. E se è così, la follia può essere guarita.

"L'alienazione non implica affatto la lesione organica del sistema nervoso ma soltanto l'alterazione delle sue funzioni." (Galzigna, 1992, p. 135)

I quattro principi di Pinel

Il prof li elenca come fondamentali ancora oggi:

1. **Guaribilità** — la follia da passioni è guaribile. L'ospedale è un luogo di passaggio, non di internamento definitivo.
2. **Principio patoplastico** (anche detto autoplastico) — la malattia si imprime su un substrato unico. Due persone con la stessa diagnosi possono esprimere la

malattia in modo completamente diverso. Esempio: due pazienti con allucinazioni — uno vede un angelo, l'altro un diavolo. Stessa allucinazione, due mondi diversi.

3. Principio di parzialità della follia — anche il "folle" conserva sempre una parte sana, ancora interlocutrice. Non ha senso attaccare frontalmente il delirio — lo si perde. Bisogna rivolgersi alla parte non malata. È come trovare in un sistema guasto il modulo che risponde ancora: non si resetta tutto, si cerca l'ingresso funzionante.

4. Trattamento morale (*traitement moral*) — la cura avviene attraverso la relazione, l'ascolto, il riordino della vita emotiva. Le passioni che hanno trascinato la ragione si regolano attraverso nuove esperienze relazionali.

Il prof segnala anche la **deriva paternalistica**: Pinel metteva in scena "finte commissioni statali" per curare pazienti con deliri persecutori — manipolazione non accettabile oggi, ma nel contesto storico era un passo avanti rispetto all'internamento coercitivo. Il paziente stava meglio, ma poi scoprì che era una farsa e peggiorò. Da queste esperienze nascerà il teatro terapeutico.

La storia del paziente: elemento centrale

Il prof collega Pinel a Donizetti: cantare al compositore le sue arie era un tentativo di raggiungerlo nel suo "altrove". Principio: per curare qualcuno devi conoscerne la storia, i gusti, le relazioni, le persone che amava.

"La cura va personalizzata." — Pezzoli

Questo vale ancora oggi: la conoscenza biografica del paziente è preconditione della presa in carico.

Esquirol: la differenziazione (inizio 1800)

Jean-Étienne Esquirol (1772–1840), allievo e continuatore di Pinel, struttura meglio la distinzione:

- **Follia da passioni** (tipo Lucia): comprensibile, trattabile con il metodo morale, potenzialmente guaribile
- **Follia organica** (tipo Donizetti): paradigma dell'incurabilità — demenza e paralisi progressiva

Esquirol distingue anche tra: - **Idiozia**: condizione di nascita (mancato sviluppo delle facoltà intellettuali) — esclusa dal campo delle malattie - **Demenza**: deterioramento acquisito che insorge nella vita (pubertà o come esito di malattia)

Importante: per Pinel ed Esquirol **l'ascolto del malato è fondamentale**. I sintomi (ciò che il paziente dice di vivere) prevalgono sui segni (ciò che il medico osserva dall'esterno). Questo cambierà radicalmente con il positivismo.

Esquirol riprende anche la **comprensibilità** della follia passionale:

"Vi ritrova le stesse idee, gli stessi errori, le stesse passioni, gli stessi infortuni: è lo stesso mondo — ma i lineamenti sono più forti, i colori più vivi, gli affetti più contrastanti." (Esquirol, 1938)

Questo filone della comprensibilità riappare nel XX sec. con **Karl Jaspers**: la follia passionale è comprensibile perché ci riconosciamo qualcosa di nostro, espresso all'estremo. Quella organica no.

Il positivismo: il trionfo dell'organicismo (XIX sec.)

Con la seconda metà dell'Ottocento, il pendolo oscilla pesantemente verso il polo organicista. La psichiatria vuole diventare scienza esatta, come la medicina del corpo.

Wilhelm Griesinger (1817–1868) lancia il motto-simbolo:

"Le malattie psichiche sono malattie del cervello" (die psychischen Krankheiten sind Erkrankungen des Gehirns)

Introduce la distinzione tra **Somatiker** (medici organicisti) e **Psychiker** (chi attribuisce la follia a cause psicologiche).

Jacob Moleschott radicalizza: "il pensiero sta al cervello come l'urina sta ai reni." Nessuno spazio per le passioni, le relazioni, la storia personale.

Morel e la teoria della degenerazione

Benedict Augustin Morel (1809–1873) introduce il concetto di **degenerazione**: sull'onda del darwinismo (*Origine della specie*, 1859), legge la follia come involuzione evolutiva — la perdita delle conquiste che la specie aveva faticosamente guadagnato.

Il percorso della degenerazione inizia con il **delirio** — e il prof spiega la struttura logica del delirio con il sillogismo:

- Premessa universale vera → conclusione corretta = pensiero sano
- **Premessa non universale + autoriferimento** = delirio

Esempio: "Lui tossisce → lui mi sfotte." La deduzione ha una logica interna, ma la premessa non è universale. È lì che salta il ragionamento — il pensiero è "di fianco" alla realtà. Da qui: *paranoia* (greco: *parà* = di fianco + *noos* = pensiero).

Per Morel la degenerazione è **progressiva e irreversibile**. Nasce qui il concetto di **demenza precoce**: la patologia si sviluppa in giovane età e porta al deterioramento cognitivo definitivo.

Lombroso e l'antropologia criminale

Cesare Lombroso (1835–1909) è la figura-simbolo del positivismo italiano. Misurava tutto: crani, tatuaggi, anomalie morfologiche. La sua teoria dell'**atavismo**: alcune anomalie corporee riavvicinano l'individuo ai primati — segnale di regresso evolutivo iscritto nel corpo.

Il prof (nel manuale) lo rivaluta parzialmente: al di là degli errori — molti e seri — Lombroso aveva un lato interessante. Portava l'attenzione scientifica sui marginali e sulla loro **biografia** come dato rilevante. La storia di vita non è separabile dalla biologia.

Aveva anche un senso bizzarro di coerenza democratica: da socialista convinto, lasciò il suo corpo alla scienza post mortem. L'autopsia rivelò che il suo cervello aveva "stimmate delinquenziali" — pieghe caratteristiche. La storia non perdona.

Krafft-Ebing (1840–1902) teorizza il "cervello debole": individui che non reggono i ritmi della civiltà moderna e scivolano progressivamente verso la marginalità.

La Pellagra: quando la povertà fa impazzire

Il manuale riporta l'esempio della **pellagra** come paradigma di causa organica-esogena che produce sintomi psichici.

La pellagra è la malattia delle **3 D**: Dermatosi, Diarrea, Demenza. In inglese si aggiunge una quarta D: *Death*.

Causa identificata: **monofagismo maidico** — dieta quasi esclusiva di mais in comunità povere (soprattutto campagne del nord Italia nell'Ottocento) con conseguente **carezza di niacina** (vitamina B3 / aminoacido essenziale).

Prima di trovare la causa, si sospettò di tutto: maffe, ereditarietà. I malati in fase avanzata finivano in manicomio. Il caso del calzolaio **Mattio Lovat** — che nel 1814 tentò di crocifiggersi a Venezia e fu internato — è uno degli esempi citati.

Il prof sottolinea che gli organicisti, cercando la causa biologica della follia, paradossalmente **denunciavano la povertà** come fattore causale — un risultato politicamente interessante, anche se ottenuto con metodo riduzionista.

Kraepelin: la mappa nosologica (fine XIX sec.)

Emil Kraepelin (1856–1926) costruisce la prima grande classificazione moderna delle malattie mentali — la base sulla quale è costruito ancora oggi il DSM.

Per Kraepelin i sintomi non vanno ascoltati ma classificati: sono **segni** di un sistema biologico che malfunziona. L'attenzione alla parola del paziente (cara a Pinel ed Esquirol) è praticamente archiviata.

Classifica le malattie in due grandi famiglie:

Malattie esogene (cause esterne): - *Psicologiche*: traumi, eventi di vita — che comunque per Kraepelin lasciano una "cicatrice" organica nel cervello - *Somatiche*: infezioni, carenze nutrizionali (es. pellagra), agenti biologici

Malattie endogene (prodotte dall'interno del SNC):

Patologia	Asse compromesso	Decorso
Psicosi maniaco-depressiva	Asse emotivo	Parzialmente reversibile
Demenza precoce	Unità interna	Progressiva, irreversibile

Psicosi maniaco-depressiva — cosa salta: - *Fase maniacale*: attenzione dispersa su tutto (e su niente), percezione superficiale, ideazione accelerata (pensieri su pensieri), ipermotilità - *Fase depressiva*: fatica a tenere l'attenzione, percezione chiusa (pochi stimoli passano), ideazione povera e fissa (ipocondria, senso di rovina), rallentamento motorio fino all'immobilità

Demenza precoce (poi schizofrenia) — cosa salta: - L'**unità interna** del soggetto: le funzioni psichiche (attenzione, percezione, ideazione, emozioni, volontà) non sono più connesse tra loro - Allucinazioni, pensiero disordinato, emozioni spente, abulia/impulsività

Bleuler: la sintesi tra organico e psicologico (1911)

Eugen Bleuler (1857–1939) — i cui assistenti includevano Carl Gustav Jung ed Eugène Minkowski — tenta una sintesi tra i due sguardi.

Nel 1911 rinomina la demenza precoce **schizofrenia** e distingue:

- **Sintomi primari** (fondamentali): conseguenza diretta del danno cerebrale; subiti passivamente dal paziente; base della diagnosi
- **Sintomi secondari** (accessori): reazione psicologica del soggetto alla sofferenza di fondo; variabili da persona a persona perché dipendono dalla soggettività di ciascuno

Recupera il principio **patoplastico** di Pinel: la malattia si esprime in modo unico su ogni persona. Il paziente non è solo il suo danno cerebrale — è anche chi reagisce a quel danno con la sua storia e la sua soggettività.

La dimensione identitaria della malattia mentale

Il prof introduce tre dimensioni che la malattia mentale mette in crisi nel soggetto:

1. **Identità** (chi sono?)
2. **Spazialità** (dove sono? essere "altrove")
3. **Temporalità** (in che tempo vivo?)

Il **vocabolario popolare della follia** è quasi tutto spaziale: "fuori di testa", "spostato", "fuori come un balcone" — linguaggio che parla di un altrove rispetto alla norma condivisa.

Il prof sottolinea una differenza linguistica fondamentale: - **Avere** una malattia → non identificazione con essa - **Essere** una malattia → identificazione identitaria

Le malattie psichiche tendono a usare l'ausiliare essere: "sono schizofrenico" più che "ho la schizofrenia". Questo non è neutro — implica due paradigmi di cura molto diversi. Se la condizione è identitaria, l'obiettivo non è la guarigione intesa

come cancellazione, ma il benessere e lo sviluppo delle possibilità all'interno di quella condizione.

La carta del Matto e la dimensione relazionale

Il prof usa la **carta del Matto dei tarocchi** (l'unica senza numero) come metafora della follia: - Non si abbina con nessun'altra carta (ma può stare con tutte) → crisi della dimensione relazionale, crisi dell'ipersoggettività - Il personaggio va armato di tutto punto a cacciare le farfalle → disallineamento tra mezzi e fini

Il DSM e il Malleus Maleficarum

Il prof fa un parallelo provocatorio tra il **DSM** e il **Malleus Maleficarum** (1486, manuale per identificare le streghe): entrambi sono sistemi categoriali che stabiliscono criteri di inclusione/esclusione.

La differenza che conta non è lo strumento ma il **fine**: diagnosticare per curare e migliorare il benessere della persona, o diagnosticare per stigmatizzare?

"Basta cambiare lo scopo e si finisce dalla cura allo stigma." — Pezzoli

Il punto di arrivo: Cargnello e l'ambiguità irriducibile

Danilo Cargnello formula la sfida fondamentale di chi lavora con la sofferenza mentale:

"Il sapersi mantenere con l'altro e non semplicemente di fronte all'altro — anche se quest'altro è uno psicotico che per natura sembrerebbe sottrarsi all'offerta di coesistenza — è un compito straordinariamente difficile." (Cargnello, 1999)

L'ambiguità della psichiatria: oscillare tra **"essere con qualcuno"** e **"avere qualcosa di fronte."** Il rischio del polo organicista è ridurre la persona a un cervello malfunzionante. Il rischio del polo psicologista è perdere di vista la dimensione biologica. La clinica — l'incontro reale — è il terreno dove questa tensione va abitata, non risolta.

L'invito non è a scegliere un paradigma, ma a stare in piedi nel mezzo.

Concetti chiave

Termine	Significato
Gehirnpsychiatrie	Psichiatria del cervello: follia come malattia organica
Geistespsychiatrie	Psichiatria della mente: follia come prodotto psicologico/sociale
Somatiker	Medici organicisti (seguaci di Griesinger)
Psychiker	Medici che attribuiscono la follia a cause psicologiche
Teoria degli umori	4 fluidi corporei (Ippocrate); squilibrio = malattia
Fluidisti	Seguaci della teoria degli umori
Nevrosi	Termine di Cullen (1777): raggruppa isteria, ipocondria e simili
Nevrastenia	"Esaurimento nervoso" (Beard): cervello come batteria scaricabile
Trattamento morale	Cura via relazione, ascolto e riordino emotivo (Pinel)
Patoplastica	La stessa malattia si esprime in modo unico su ogni persona
Parzialità della follia	

Termine	Significato
	Nel malato c'è sempre una parte sana — ci si rivolge a quella
Guaribilità	La follia da passioni è curabile (Pinel)
Degenerazione	Morel: follia come involuzione evolutiva, progressiva e irreversibile
Delirio paranoico	Ragionamento su premesse non universali + autoriferimento
Paranoia	Dal greco <i>parà</i> (di fianco) + <i>noos</i> (pensiero): pensiero parallelo
Demenza precoce	Kraepelin: patologia endogena; Bleuler la rinomina schizofrenia (1911)
Schizofrenia	Termine di Bleuler (1911): perdita dell'unità interna del soggetto
Psicosi maniaco-depressiva	Patologia endogena: oscillazione maniacale ↔ depressiva
Alienazione	Uscire dal proprio mondo — essere "altrove"
Comprensibilità (Jaspers)	Follia passionale = comprensibile; follia organica = no
Pellagra	Malattia da carenza di niacina (monofagismo maidico): 3 D
Atavismo	Lombroso: anomalie corporee come segni di regresso evolutivo

Collegamenti

- **Lezione 01:** Primo incontro con il modulo — contesto clinico, principio di presenza autentica, storie personali della comunità. Già emersi: fragilità vs. vulnerabilità, silenzio che crea solitudine vs. silenzio che accoglie.
- **Lezione successiva:** Psicosi, disturbi specifici dell'area psicotica, affettività come fattore di rischio — si riprende la nosologia di Kraepelin e Bleuler.
- **Modulo di Cinzia Campello:** disturbi di personalità, teoria degli umori — ripresa esplicita citata in lezione.
- **Temi aperti:** integrazione farmacologica e psicologica (i farmaci trattano i sintomi, non la causa; l'esempio del dipendente che viene disintossicato ma non affronta il motivo per cui usava la sostanza); il rischio del maltrattamento nelle case anziani quando la persona smette di essere vista come persona (collegato al tema dell'Alzheimer e di Donizetti).